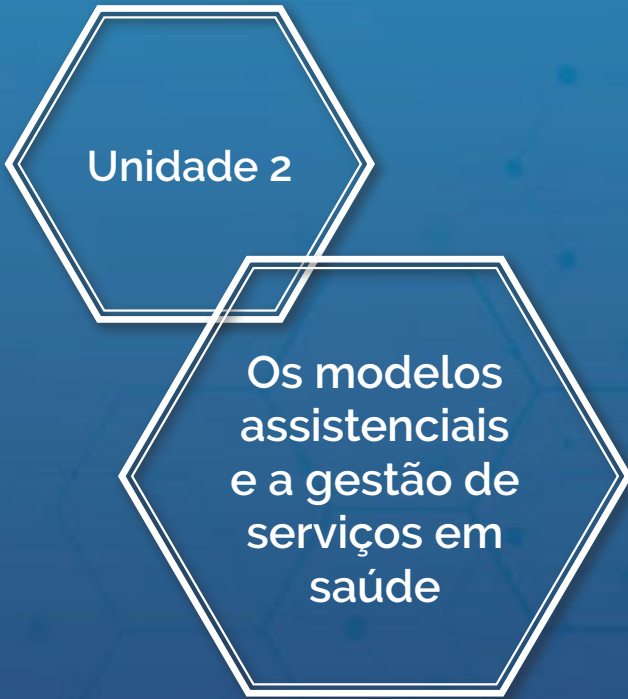


Modelos e Gestão de Serviços em Saúde

HERMÍNIO OLIVEIRA MEDEIROS



Unidade 2

Os modelos
assistenciais
e a gestão de
serviços em
saúde



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
HERMÍNIO OLIVEIRA MEDEIROS

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

O AUTOR

Hermínio Oliveira Medeiros

Olá! Meu nome é Hermínio Oliveira Medeiros. Sou graduado em Farmácia (Universidade Federal de Ouro Preto, 2005) e em Sociologia (UNIP, 2018). Sou mestre em Administração em Saúde (Udelmar, 2014), pós-graduado com MBA em Gestão de Negócios (Univiçosa, 2012) e especializado em Gestão em Logística Hospitalar (FINOM, 2009), em Qualidade e Acreditação Hospitalar (FCMMG, 2014) e em Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente pela (ENSP/FIOCRUZ, 2017). Atuo na docência de cursos superiores da saúde e na gestão de saúde pública e hospitalar. Por isso fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Meu nome é Manuela César de Arruda. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Modelos Assistenciais em Saúde 11

Introdução aos modelos assistenciais 11

Modelos de assistência na saúde..... 13

Construção de um modelo assistencial 15

Operacionalização da Assistência em Saúde 17

Análise crítica dos modelos de assistência em saúde..... 19

Modelos Assistenciais: Desafios e as Estratégias para a Organização dos Serviços de Saúde 22

Implementação de Modelo Assistencial à Saúde..... 22

Gestão, Formação Profissional e Cultura Popular..... 23

Análise crítica de modelos de gestão em saúde 27

Custos nos modelos de assistência 30

Modelos e Estratégias da Gestão em Saúde 33

Gestão da qualidade..... 33

Gestão estratégica 35

Visão Tático-operacional..... 38

Planejamento e Implementação de um Modelo Assistencial em

Saúde	39
-------------	----

Planejamento Estratégico Situacional	40
--	----

Desafios para a Organização dos Serviços de Saúde no Brasil

Contemporâneo.....	44
---------------------------	-----------

O SUS e o Estado.....	44
-----------------------	----

Estudos de Avaliação Econômica em Saúde	46
---	----

Economia de Escala	48
--------------------------	----

Incorporação tecnológica em saúde.....	49
--	----

Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS)	52
--	----

UNIDADE

02

OS MODELOS ASSISTENCIAIS E A GESTÃO
DE SERVIÇOS EM SAÚDE

INTRODUÇÃO

Prezado aluno! Ainda hoje em nosso país a gestão dos sistemas e serviços públicos de saúde acaba, por questões de cunho político, sendo delegada à pessoas sem a devida qualificação para atribuição de tamanha complexidade e responsabilidade. Sabe-se também que, historicamente, os sistemas públicos de saúde do Brasil são marcados pela carência de recursos, tidos sempre como insuficientes para suprir a demanda crescente da população. Nesse contexto, será a especialização dos profissionais da gestão a solução para os problemas atuais da saúde no país? Vamos discutir a legislação, os modelos e a gestão dos serviços de saúde no Brasil e como a profissionalização da gestão contribui de forma inequívoca para o alcance da eficácia, da eficiência e da efetividade administrativa em saúde. Vamos lá! Bons estudos!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 2 – Os modelos assistenciais e a gestão de serviços em saúde**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Executar análise crítica dos modelos de gerência e modelos de assistência à saúde;
2. Desenvolver visão macro, estratégica e tática sobre gestão em saúde;
3. Compreender a realização de análise econômicas em saúde;
4. Entender a alocação de recursos em saúde.

Então? Preparado para adquirir conhecimento sobre um assunto fascinante e inovador como esse? Vamos lá

Modelos Assistenciais em Saúde



INTRODUÇÃO:

Prezado aluno, veremos nesse capítulo como uma gestão eficiente na saúde pública passa pela compreensão dos modelos assistenciais e gerenciais em saúde demonstrando a importância do árduo trabalho de construção e de implementação daquele modelo idealizado por todos, e coerente com as bases doutrinárias do SUS. Preparados? Vamos lá!

Introdução aos modelos assistenciais

Gerir e financiar o sistema de saúde brasileiro (Sistema Único de Saúde ou somente SUS) é um grande desafio. Seus princípios e o modo como foi idealizado, claramente visível através da leitura de sua legislação de constituição e posteriores, faz com que a sua redação seja considerada como um exemplo para o mundo.



REFLITA:

Será que esses fundamentos estão sendo respeitados ou o SUS não passa de um sistema teórico e impraticável?

O direito à saúde universal e gratuita no Brasil representa uma das maiores conquistas do cidadão dentro da seara dos direitos sociais e foi resultado de muita mobilização por parte da população durante toda a história do país. Podemos permitir que nossos direitos constitucionais sejam cerceados pela ingerência e pela precariedade administrativa?

Governantes e gestores têm a diária luta de buscarem alternativas para a operacionalização do SUS, o que o torna dinâmico, em constante mutação nessa busca de excelência. Mas talvez não seja o próprio modelo de atenção vigente (arraigado há tempos na nossa cultura) um dos fatores dificultadores desse processo de garantia dos direitos no SUS?

**NOTA:**

Analisando todo o histórico, o arcabouço legal e os princípios do SUS e fazendo um comparativo com sistemas de saúde de outros países ao redor do globo, realmente nos deparamos com um belíssimo sistema de saúde. Seria utopia esperar um sistema tão perfeito ou podemos construir, conjuntamente, um SUS melhor?

O SUS, apesar de promover o acesso à todos os níveis de atenção, traz como diretriz a operacionalização de seus princípios fundamentais na atenção primária, pautada em ações educativas, preventivas, de menor complexidade e à nível local.

**IMPORTANTE:**

Esse foco na atenção primária à saúde pode ser uma forma de se promover a qualidade de vida pelo não-adoecimento de uma população cada vez mais envelhecida. Assim, em uma realidade de envelhecimento da população e o consequente aumento das doenças crônicas ligadas à idade, a busca por hábitos de vida saudáveis demonstram ser a ação mais efetiva na prevenção de doenças, no aumento e na manutenção da qualidade de vida.

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a Estratégia Saúde da Família (ESF) como forma de reorganização da atenção básica no país. A estratégia vislumbra a expansão, a qualificação e a consolidação da atenção à saúde por promover reorientação do processo de trabalho, pautado na equipe multiprofissional, ampliando a resolutividade e propiciando a otimização dos recursos financeiros por se possuir uma importante relação de custo-efetividade, importantes fatores no atual cenário da saúde pública brasileira (BRASIL, 2012).

**ACESSE:**

O documentário "Sicko: SOS Saúde", produzido nos EUA, reflete a realidade da saúde pública norte-americana onde não há sistema de saúde universal e gratuito, e o acesso aos serviços se dá através dos planos de saúde caros e, muitas vezes, inacessíveis à parcela carente da população (MOORE, 2007).

Modelos de assistência na saúde

Um modelo assistencial é a maneira como são organizadas, em uma dada sociedade e em seu tempo, as ações de atenção à saúde, envolvendo a articulação entre os diversos recursos envolvidos no cuidado como os humanos, físicos e tecnológicos disponíveis para atender os problemas de saúde de uma sociedade.

**NOTA:**

Considerando-se que os modelos assistenciais se baseiam na compreensão da saúde e da doença, e nas tecnologias disponíveis em determinado período social, observando-se as políticas e a ética vigentes, não se pode dizer que existem modelos certos ou modelos errados, mas sim, aquelas que dão certo ou não quando seguidas (SILVA JUNIOR; ALVES, 2007).

Bassinello (2014) relata que o modelo de atenção à saúde, atualmente, vigente no SUS apresenta fragilidades dentre as quais a fragmentação que dificulta a comunicação entre os pontos de atenção do sistema, a carência de sistemas logísticos e a fraca governança das redes de atenção à saúde.

**IMPORTANTE:**

Busato (2017) explica que as portas de entrada do SUS nas Rede de Assistência à Saúde (RAS) são aquelas dos serviços de atenção primária, de urgência e de emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto, como hospitais e serviços especializados, logo, toda a rede do cuidado é influenciada pelo modelo assistencial vigente.

O conceito de modelos assistenciais em saúde apresentado em Faria et al. (2010) relaciona-se à análise de sistemas de saúde existentes ou que já existiram em diferentes sociedades e, a partir daí, examiná-los e compará-los através de uma metodologia de compreensão não apenas dos arcabouços organizacionais que lhes sustentam, mas também dos paradigmas científicos ou dos pensamentos por trás desses modelos.

**ACESSE:**

A OMS considera o sistema público de saúde da França como o melhor do mundo por oferecer os melhores cuidados de saúde em geral à sua população (OMS, 2012). Pesquise em <https://bit.ly/2xTZldY>

No Brasil, podemos identificar diversos modelos de assistência à saúde em diferentes períodos da história do país. No início da República, por exemplo, o sanitarismo era presente, valendo-se de políticas públicas para as campanhas de vacinação compulsória contra as epidemias do momento, com interesses políticos e econômicos, modalidade de intervenção ainda utilizada no combate às endemias e às epidemias no país.

Já o famoso modelo de medicina voltado para a assistência à doença em seus aspectos individuais e biológicos, hospitalocêntrico, com forte especialização médica e uso intensivo de tecnologia é denominado modelo biomédico (ou medicina científica ou biomedicina ou modelo flexneriano) (SILVA JUNIOR; ALVES, 2007).



VOCÊ SABIA?

O termo "flexneriano" é uma homenagem a Abraham Flexner, médico cujo relatório, em 1911, fundamentou a reforma do ensino médico nos EUA e Canadá, estruturando toda a assistência médica da primeira metade do século XX e deixando fortes influências até a atualidade (PAGLIOSA; DA ROS, 2008).

Atualmente, no país o que se vê é a busca pela implantação de um modelo assistencial que atenda às nossas políticas de saúde tornando-as factíveis, eficientes e resolutivas.

Construção de um modelo assistencial

A Estratégia de Saúde da Família pode ser entendida como a formulação de um modelo assistencial que indica problemas e soluções modelares renovando e produzindo novas ferramentas alternativas às opções existentes que até o momento não conseguiram se desvencilhar do modelo biomédico flexneriano.



IMPORTANTE:

O modelo Saúde da Família emergiu na década de 90, no Brasil, fomentando a mudança no modelo assistencial em para atender à demanda da criação do SUS. Contudo, é na sua dimensão político-operacional que se encontra o grande desafio da construção da Estratégia de Saúde da Família - ESF (FERTONANI et al., 2015).

Para atender à essas características da ESF, com foco na atenção básica, preventiva e de baixa complexidade, esse modelo ideal precisa partir da compreensão da saúde-doença como um processo político, histórico, sociológico e determinado condicionantes sociais.

O modelo deve ainda focar suas ações na promoção da saúde, reconhecer a saúde como direito cidadão e nortear-se pelos princípios e

pelas diretrizes do SUS, destacando-se a universalidade, a acessibilidade, a continuidade do cuidado, a integralidade, a responsabilização, a humanização, o vínculo, a equidade, a participação, a resolubilidade e a intersetorialidade (FARIA et al., 2010).



SAIBA MAIS:

O financiamento de um sistema de saúde gratuito, integral e universal em um país de mais de 207 milhões de pessoas onde mais de 70% da população depende unicamente dos serviços públicos de saúde (BRASIL, 2013). Leia mais sobre esse desafio em: < <https://bit.ly/3aRnOzk> >.

Esse é o grande desafio da saúde pública brasileira: implementar efetivamente um modelo de assistência que busque a promoção da saúde, que incentive o protagonismo dos usuários e que fuja do modelo biomédico ainda muito presente na nossa cultura e no ensino acadêmico dos profissionais de saúde, ou seja, construir um modelo “alternativo” novo, mas que mescle o melhor de todos os disponíveis.

Os movimentos atuais que se esforçam na construção de um novo modelo caminham para que se conserve bases do modelo tradicional o que pode gerar, ora convivência conflituosa, ora complementar entre ambos.



NOTA:

Destacam-se, neste contexto, os movimentos que priorizam o cotidiano do trabalho em saúde, as relações interpessoais, o envolvimento e a corresponsabilização (de gestores, de profissionais de saúde e de usuários) na atenção à saúde, redesenhando as relações de vínculo, as ações de acolhimento e a humanização do cuidado em saúde (FARIA et al., 2010).

Desse modo, podemos concluir que o modelo assistencial é uma construção baseada na realidade social, nas suas necessidades e nas expectativas, em um certo período histórico e que se redesenha continuamente, um processo altamente dinâmico em prol da melhoria contínua da qualidade de vida e saúde da população, prioridades de um sistema de saúde pautado nas pessoas e na inclusão social como é o SUS.

Operacionalização da Assistência em Saúde

A operacionalização da assistência idealizada nos modelos e preconizada nas políticas de saúde é etapa essencial para a efetivação dos direitos constitucionais do cidadão brasileiro, já que possuímos um sistema de saúde que trabalha teoricamente na redução das desigualdades sociais com grandes problemas de concretização prática.



REFLITA:

Nesse contexto, uma gestão profissional, que busque a eficiência alocativa dos recursos financeiros e a qualidade dos serviços prestados, pode ser a solução para os problemas do SUS.

Sabe-se que a gestão em saúde tenta utilizar-se de modelos administrativos exitosos na área privada e já testados previamente em outros países, porém, ainda com grandes dificuldades de aceitação e de operacionalização no país.



REFLITA:

Os gestores devem procurar utilizar-se de ferramentas modernas da Administração na busca da gestão adequada do SUS uma vez que, mesmo com as características específicas do setor público brasileiro, elas permitem ampla aplicação.

As Normas Operacionais Básicas do SUS, NOB-SUS (BRASIL 1991; 1992; 1993; 1996), promoveram integração das ações de saúde entre as três esferas de governo e desencadearam o processo de descentralização, delegando, principalmente aos municípios, responsabilidades e recursos para a operacionalização do SUS, antes centralizadas no nível federal.

**NOTA:**

Com o advento da Norma Operacional da Assistência à Saúde, NOAS-SUS (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002), apresentou-se a confirmação de algumas diretrizes e a ampliação de outras.

Podemos citar de grande repercussão na NOAS-SUS as diretrizes de descentralização, de regionalização, de ampliação de acesso à saúde com a definição de áreas estratégicas de atuação, da organização de serviços, tanto em atenção primária quanto em média e alta complexidades; o fortalecimento da capacidade de gestão no SUS; além da definição das responsabilidades de cabíveis às esferas de governo garantia o acesso da população, o controle, a avaliação e a regulação dos serviços.

**EXPLICANDO MELHOR:**

Com a NOAS-SUS os municípios passaram a ter responsabilização até então nunca preconizada na gestão da atenção básica, e incorpora em seu texto, claramente, conceitos e critérios modernos da gestão em saúde, na busca de eficiência dos serviços, influenciando e promovendo a necessidade de os gestores se capacitarem para o atendimento a esses requisitos.

Desse modo, coube ao município se capacitar para ter a competência de planejar, de executar, de avaliar, de controlar e de regular as suas ações de saúde, demandando uma equipe especializada em gestão com habilidades técnicas para realizar a construção, a implementação e a análise crítica das políticas de saúde.

Análise crítica dos modelos de assistência em saúde

É real a necessidade de reorientação do modelo assistencial da saúde. Para isso, deve-se estimular a reflexão sobre o trabalho das equipes de saúde, o uso de tecnologias, a formação profissional e a alocação dos recursos (ALMEIDA, 2012).



IMPORTANTE:

No aspecto administrativo, os gestores precisam desenvolver mais a competência para trabalharem com indicadores de saúde. Taxas, índices, dentre outros, são números, informações que proporcionam ao gestor realizar análise crítica do processo gerencial e da efetividade do modelo de assistência adotado, que, em saúde, reflete diretamente na qualidade de vida da população assistida.

Cabe ao gestor analisar se o modelo de gerência ou assistencial, ora adotado, não apresenta a efetividade almejada, mapear os processos, identificar os pontos de melhorias e propor medidas interventivas que busquem a criação ou adaptação de um sistema que atenda às reais necessidades dos usuários.

Figura 1 – Os gestores precisam analisar o financiamento dos modelos de assistência em saúde.



Fonte: Pixabay

Através do estudo dos indicadores, os gestores devem analisar o foco, o financiamento, o território, as tecnologias, as equipes e os usuários, todos componentes do complexo sistema de saúde que se pretende desenhar.



IMPORTANTE:

A intervenção nesses aspectos do sistema deve ser analisada quanto aos impactos diretos e indiretos na operacionalização das ações de saúde e, obviamente, na qualidade de vida e de saúde dos usuários.

O Modelo Médico-Assistencial Privatista (hegemônico) tem foco no atendimento de demanda espontânea, residindo aí a sua maior deficiência por não alcançar aquela parcela da população que não percebe suas necessidades de saúde, mesmo que estas existam.



NOTA:

Porém, mesmo atualmente, parte dos profissionais e dos usuários não valorizam a prevenção de doenças, refletindo o modelo assistencialista centrado na figura do médico e no hospital que não verifica as necessidades locais, a formação de vínculos e o protagonismo da população assistida.

Logo, o grande impacto negativo da gestão e do modelo predominantemente curativo é o prejuízo ao atendimento integral individual e coletivo, o não comprometimento com o resultado sobre o nível de saúde da população e a elevação dos custos da assistência (ALMEIDA, 2012).



RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que um dos principais fatores de sucesso (ou fracasso) de um sistema de saúde é o foco em um modelo de assistência que preze pelo atendimento de forma efetiva das necessidades de saúde da população de maneira financeiramente viável. Assim, construir e implantar um modelo de assistência realmente efetivo passa pela capacidade do gestor de analisar, planejar e operacionalizar políticas e ações de saúde, resolutivas, efetivas e a um custo acessível. No Brasil, sabemos que foi eleito o modelo de assistência que foca na atenção primária à saúde (atenção básica), que trabalha no âmago das comunidades, respeitando as suas características e necessidades reais, com ações educativas e preventivas que visam a qualidade de vida e saúde, tentando fugir do antigo modelo ainda forte em nossa cultura que privilegia a doença e os tratamento de maiores complexidades e custos.

Modelos Assistenciais: Desafios e as Estratégias para a Organização dos Serviços de Saúde



INTRODUÇÃO:

Neste capítulo veremos que persiste o desafio da construção de um modelo de assistência que promova a saúde, pautado em ações preventivas, na educação, no acolhimento e na humanização é ainda prejudicado pela centralidade do modelo incrustado em nossa cultura que preza pelo tratamento curativo de doenças. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Implementação de Modelo Assistencial à Saúde

A implementação de um modelo de assistência à saúde requer a participação de todos os atores envolvidos na construção cotidiana da saúde pública: gestores, profissionais de saúde e usuários.

Precisamos promover a reflexão sobre o modelo assistencial em saúde e os desafios da atenção no país que busca na saúde da família a ampliação do acesso às ações de promoção à saúde, o acolhimento e a humanização das práticas. Porém observa-se que permanece a centralidade das ações destinadas ao tratamento de patologias e dos cuidados ao corpo biológico.

Somente alterando o modelo assistencial implantado teremos a almejada qualidade em saúde ou precisamos modificar a formação acadêmica dos profissionais da saúde e a maneira do povo de lidar com o conceito de "saúde" e "doença"? Será que podemos retirar o que o paradigma biomédico trás de melhor e adaptá-lo, juntamente com outros ideais metodológicos da assistência e de gestão, e, de acordo com as nossas características próprias, transformá-lo no nosso modo de pensar, de gerir e de fazer saúde pública?

Essa característica dificulta a efetivação da integralidade e influencia a formação acadêmica, a prática profissional e as relações de trabalho da equipe multidisciplinar. Embora tenhamos propostas e políticas estruturantes de um modelo assistencial que avance frente à doutrina biomédica ainda vigente, são grandes as dificuldades para sua implementação (FERTONANI et al., 2015).

Baseando-nos no em Paim (1999) onde o autor definiu “modelos de atenção à saúde ou modelos assistenciais” como a combinações de recursos e tecnologias materiais e não-materiais empregadas nas intervenções destinadas à solução dos problemas e das necessidades sociais de saúde.



IMPORTANTE:

À época, modelos alternativos apareceram no país como a oferta organizada ou programada, a vigilância da saúde, as ações programáticas, a saúde da família, definidos em políticas públicas que determinavam o foco das ações de saúde, a participação da equipe multiprofissional, da população e as responsabilidades da gestão.

Gestão, Formação Profissional e Cultura Popular

A implementação de um modelo de assistência que respeite as características e as necessidades de saúde de uma população engloba a participação de todos os atores sociais envolvidos nesse processo de construção.



IMPORTANTE:

Estudos demonstram que a incompreensão por parte da gestão acerca do aspecto multifatorial, da multidisciplinaridade, da estrutura dos serviços e dos processos gerenciais representam os maiores desafios na construção do modelo ideal para a saúde pública.

Ainda são insatisfatórios os espaços voltados à construção coletiva de novas práticas de saúde pela carência dos diálogos entre gestores, profissionais e usuários, que mais se dedicam ao debate da organização e ao financiamento do sistema do que ao debate sobre a construção de um modelo efetivo de assistência à saúde (FERTONANI et al., 2015).

Cabe aos gestores da saúde utilizar-se de ferramentas que lhes permitam analisar as características próprias da sua comunidade, para assim gerar um programa de trabalho que aproxime o modelo concreto de assistência em sua cidade do modelo ideal (FARIA et al., 2010).

Figura 2 – O envelhecimento populacional impacta no modelo de assistência ideal.



Fonte: Freepik



NOTA:

Um modelo de assistência à saúde deve considerar as características da população assistida e a realidade vigente em sua época.

Para Morosini (2007), a gestão da saúde deve, na busca de um modelo ideal, ser democratizada, visando a horizontalização dos organogramas e a construção de espaços coletivos de discussão, apontadas como instrumentos de promoção de maior participação dos profissionais e da população.

**NOTA:**

A construção coletiva dos desenhos tecnoassistenciais, a estrutura e os processos de gestão, bem como a viabilização de uma gestão participativa o se constituem como grandes desafios (MOROSINI, 2007).

Nesse sentido, além dos esforços dos gestores, é necessário o engajamento da equipe multiprofissional da saúde, que, às vezes, não possui formação acadêmica voltada a um novo modelo de assistência, sendo ainda difusores da dinâmica biomédica.

A exemplo do que ocorre em outros países que buscam a construção de um modelo de assistência à saúde ideal, no Brasil esse movimento necessita da fundamental participação dos profissionais de saúde devido à sua visão sobre as peculiaridades da situação de saúde da comunidade onde estão inseridos, que reflete a realidade política e social de cada período (CORREIA et al., 2010).

**IMPORTANTE:**

Silva Junior e Alves (2007) defendem que é de responsabilidade da equipe profissional exercer as capacidades de reconhecer o contexto, a comunicação, o acolhimento, a escuta e a compreensão dos diferentes valores e culturas para mobilizar soluções em resposta às necessidades de saúde da comunidade. Para tal, esses profissionais devem possuir uma formação mais social, ampla e contextualizada.

Figura 3 – Construção do planejamento das ações de saúde pela equipe multiprofissional.



Fonte: Freepik

As bases curriculares devem proporcionar à formação de um profissional de saúde que cumpra seu importante papel na construção e na consolidação de estratégias que promovam o desenvolvimento de um Sistema Único de Saúde com as características necessárias ao atendimento das necessidades da população. Nesse sentido, a formação acadêmica deve ser direcionada para a realidade sociocultural do país e suas regiões (FARIA et al., 2010).

O trabalho em equipe multiprofissional precisa ser também intersetorial. Deve articular-se com outros setores para trabalharem, conjuntamente, os determinantes sociais do processo de saúde-doença.

Embora muitas características dos modelos de assistência antigos permaneçam intactas e vigentes, parece estar emergindo um modo atualizado de atenção e de gestão no SUS, e de formação dos profissionais de saúde pela educação permanente em saúde para a conscientização sobre um novo modo de se enxergar a saúde que considere a cultura e a participação popular (SILVA JUNIOR; ALVES, 2007).

Delineando-se a filosofia dos modelos assistenciais observa-se, ainda, pouca ênfase na análise dos determinantes do processo saúde-doença. Fertonani et al. (2015) aponte para deficiências que envolvem a orientação para a demanda espontânea, o distanciamento dos aspectos culturais e éticos que regem as escolhas e vivências dos indivíduos, e a incapacidade de compreender a multidimensionalidade do ser humano.

**NOTA:**

Na construção de um modelo assistencial para o SUS é importante se promover uma mudança de cultura de gestores, de profissionais e de usuários, levando a uma melhor qualidade na prestação de serviços a nível nacional e local (FARIA et al., 2010).

A população precisa aceitar as estratégias formuladas baseadas na medicina preventiva, fundamentada em uma abordagem integral do homem, entregando-se ao protagonismo no cuidado à sua saúde.

**IMPORTANTE:**

A medicina preventiva propõe o cuidado próximo do ambiente sociocultural dos indivíduos e de suas famílias, fomentando a prevenção e o controle do adoecimento. Para isso, os usuários precisam estar engajados nesse processo construtivo da saúde individual coletiva (MOROSINI, 2007).

Identificado um modelo assistencial ideal, adaptado à realidade de uma população, caberá à gestão a adoção de uma postura gerencial que lhe proporcione suporte para a operacionalização eficiente.

Análise crítica de modelos de gestão em saúde

É fato que precisamos de novos modelos de gestão em saúde para que as organizações alcancem níveis de excelência na prestação

de serviços ofertados à população. Pelo que já se evoluiu na área, não é mais possível a adoção de modelos obsoletos de gestão pautados na hierarquia, na divisão do trabalho, no controle rígido, pois a atual contingência exige arranjos organizacionais participativos, integrativos e direcionados aos objetivos, às necessidades e às expectativas sociais (TAMADA; BARRETO; CUNHA, 2013).

Figura 4 – O excesso de burocracia é prejudicial às políticas de saúde.



Fonte: Freepik



NOTA:

A gestão da saúde pública no Brasil ainda é marcada pela baixa produtividade e pelo excesso de burocracia.

Destaca-se, como fator negativo, a alta rotatividade dos gestores na área da saúde pública, e a dificuldade de se atuar em modelos de gestão diferentes dos tradicionais.



IMPORTANTE:

Nesse contexto, o trabalho baseado em ações centralizadoras, hierarquizadas e burocratizadas, trazem como consequência trágica a incapacidade gerencial, distante de alcançar a eficiência idealizada e de atender às necessidades e a complexidade do setor saúde (LORENZETTI et al., 2014).

**NOTA:**

A gestão da saúde pública no Brasil é marcada pelo excesso de burocracia e pela baixa produtividade, o que acaba por elevar o custo dos serviços. Assim sendo, setor público da saúde precisa pensar em redução de custos (com eliminação de desperdício e retrabalho); aumento da qualidade de atendimento; e da capacitação profissional de suas lideranças (LIMA, 2007).

Não há dúvidas sobre o tamanho do desafio que é a gestão da saúde pública brasileira, sendo necessário uma visão holística sobre o funcionamento do setor por parte dos governantes e dos gestores para se buscar propostas resolutivas para a qualidade nos serviços de saúde.

Pela complexidade que envolve, a gestão em saúde pública demanda que o gestor possua uma capacidade de enxergar o sistema de saúde como um todo. A função engloba a gestão de redes, as unidades de saúde, os hospitais, laboratórios, as clínicas e demais serviços de saúde públicos, trabalhando em um uníssono em prol da qualidade de vida e da saúde da população.

De acordo com Lorenzetti et al., (2014) abrange três grandes dimensões: os cuidados diretos (singulares e multidisciplinares); as diversas instituições de saúde; e a operacionalização da redes de saúde voltadas para a assistência universal, integral, de qualidade e eficiente para as necessidades de saúde da população.

**NOTA:**

Essa afirmação, além de envolver os preceitos da administração, traz os valores que orientam a concepção de saúde e de direito do cidadão. De um modo geral, a gestão em saúde consiste em uma resposta política frente aos problemas de saúde pública, considerando custos, demandas e a legislação da saúde do país (FERTONANI et al., 2015).

O gestor deve desenvolver essa capacidade de enxergar todas as peças que compõem o sistema, conhecer e compreender toda a legislação inerente, organizar o trabalho multiprofissional e ser sensível às necessidades sociais e de saúde da população.

Assim, esse "olhar macro" sobre o setor saúde, apesar de complexo é possível, respeitando todos os atores envolvidos, buscando os objetivos do processo, a eficácia, o atendimento das expectativas dos usuários, a eficiência na otimização dos recursos, a gestão dos custos de todo o processo, dentro da legislação (LIMA, 2007).



NOTA:

É preciso definir-se os objetivos do processo para se alinhar e focalizar os pontos a serem trabalhados ou melhorados (LIMA, 2007).

Tamada, Barreto e Cunha (2013) destacam alguns modelos de gestão em saúde atualmente utilizados como alternativas à superação dos tradicionais e obsoletos ainda vigentes no país. Dentre eles, a Gestão da Qualidade, das Redes de Atenção à Saúde – RAS, da Gestão Estratégica e da Gestão Participativa – Cogestão. Discutiremos todos eles juntos ao longo da nossa disciplina.

Custos nos modelos de assistência

A gestão de custos no setor da saúde pública, como em qualquer organização privada, proporciona ao gestor uma visão fina da realidade financeira por permitir analisar como são aplicados os recursos disponíveis, identificando os exageros e destinando os recursos na quantidade certa para serem aplicados nas atividades primordiais, nesse caso, definidos pelo modelo de assistência que norteou a elaboração das políticas (ALMEIDA; BORBA; FLORES, 2009).



NOTA:

A gestão de custos não tem como objetivo somente, gastar menos, mas sim otimizar os gastos (ALMEIDA; BORBA; FLORES, 2009).

A gestão de custos no ente público é critério fundamental na tomada de decisão, pois faz-se indispensável na programação adequada dos limitados recursos financeiros disponíveis para a execução das políticas de saúde, uma otimização de gastos refletirá no aumento da quantidade e da qualidade dos serviços prestados.



NOTA:

Podemos dizer que, no setor público, a gestão de cursos permite melhor visualização do cenário financeiro e a busca na melhoria contínua da eficiência no direcionamento dos recursos e aplicação nas estratégias e ações de saúde (SILVA, SILVA; PEREIRA, 2016).

Estudos do setor público brasileiro, em geral, demonstram a necessidade da gestão de custos. A saúde, por ser bastante complexa e composta por diversos tipos de ações, de procedimentos, de profissionais e de inúmeros empreendimentos realizados dentro de uma única organização, possui características muito próprias, o que torna o apuração e a análise de custos uma tarefa desafiadora para os gestores que buscam o planejamento e a implementação de um modelo de assistência coerente (ALMEIDA, BORBA; FLORES, 2009).



RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que grandes desafios persistem na implantação de um modelo assistencial de saúde, mas que estratégias podem ser aplicadas no intuito de vencer as barreiras históricas, culturais e financeiras impostas. Vimos que é importante o alinhamento a gestão com a formação profissional e a alteração da cultura popular para que as políticas de saúde sejam efetivas e a gestão especializada apresente o resultado esperado por todos os atores envolvidos. É muito importante, nesse quesito, que a equipe multiprofissional em saúde participe ativamente no planejamento e na construção das ações de saúde em todos os níveis da atenção. Discutimos que existem modelos de gestão em saúde que devem ser aplicados para auxiliar o gestor a obter sucesso em sua complexa, delicada e importante tarefa que impacta diretamente na saúde de toda a população. Por fim, aprendemos a importância de o gestor em saúde possuir as habilidades e as competências necessárias à análise crítica de todos os aspectos que envolvem a gestão dos serviços de saúde, incluindo os fatores assistenciais e administrativos, como custos.

Modelos e Estratégias da Gestão em Saúde



INTRODUÇÃO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como modelos e estratégias de gestão distintas podem contribuir na efetivação das políticas de saúde. Estudaremos, nesse momento, a gestão pela qualidade e a gestão estratégica. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Gestão da qualidade

A busca pela garantia da qualidade nos serviços de saúde não é recente e sua evolução está presente ao longo da história. A criação de instrumentos destinados à melhoria da qualidade da assistência à saúde tornou-se um fenômeno universal nas últimas décadas, deixando de ser um conceito teórico para concretizar-se na prática cotidiana das ações de saúde, representando uma responsabilidade ética e social (LABBADIA et al., 2004).

No quesito da prestação de serviços de saúde, a gestão da qualidade busca o atendimento aos requisitos dos usuários do sistema de saúde, e, para isso, utiliza-se de ferramentas em torno do qual a gestão pode se reestruturar para fazer face às reais necessidades de saúde da população (CORNETTA; FELICE, 1994). No SUS, os requisitos dos usuários podem ser avaliados a partir do respeito aos princípios finalísticos do SUS.



NOTA:

Os sistemas de gestão são estabelecidos e implementados para facilitarem o controle e a consistência do serviço, parametrizando normas técnicas a serem seguidas e gerindo sua implantação de acordo com os princípios do ciclo do PDCA (planejar, executar, avaliar e agir).

Tal implementação proporciona uma visão integrada da tríade "estrutura-processo-resultado" que irão servir de embasamento para a determinação dos principais indicadores utilizados na avaliação da qualidade de serviços de saúde.



SAIBA MAIS:

O livro "Gestão Estratégica na Saúde. Reflexões e práticas para uma administração voltada para a excelência" apresenta para os gestores ferramentas modernas para uma gestão focada na estratégia e na qualidade (TAJRA, 2010). Leia mais em TAJRA, S. F. Gestão Estratégica na Saúde. Reflexões e práticas para uma administração voltada para a excelência" apresenta para os gestores ferramentas modernas para uma gestão focada na estratégia e na qualidade. 2. ed. Editora Iatria. São Paulo, 2010.

Donabedian (1980, apud PORTELA, 2000) propõe sete atributos, tidos como de pilares da qualidade: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade. Desses atributos, três apresentam interesse especial para o controle da qualidade em saúde: eficácia, efetividade e eficiência.



NOTA:

Tais indicadores de qualidade em saúde são parâmetros pré-determinados que, após auditoria ou avaliação, determinam o grau de qualidade dos serviços prestados aos usuários de acordo com a competência da gestão e equipe em implantá-los.

No Brasil, o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica – PMAQ-AB, tem como principal meta incentivar os gestores e as equipes de saúde a melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários no âmbito do SUS. Para tal, propõem-se um grupo de estratégias de qualificação, de acompanhamento e de avaliação

das ações e do trabalho das equipes de saúde. O programa baseia-se no incentivo financeiro federal para os municípios participantes que atingirem melhorias no padrão de qualidade no atendimento (BRASIL, 2015).

Alguns pontos se destacam entre os objetivos gerais e específicos do PMAQ: inicialmente, explicita objetivos finalísticos como a promoção da mudança, tanto no modelo de atenção quanto de gestão, impactando no cenário da saúde da população, promovendo o desenvolvimento dos trabalhadores e orientando quanto aos serviços em função das necessidades e satisfação dos usuários do SUS (PINTO, SOUSA e FERLA, 2014).



NOTA:

Pode-se observar claramente na política do PMAQ a busca da implementação de ações de saúde de qualidade, baseadas em um modelo assistencial em coerência com as necessidades dos usuários e respeitando os princípios e as diretrizes do SUS.

Gestão estratégica

O planejamento estratégico situacional (PES) é um processo contínuo muito utilizado no planejamento em saúde tem por objetivo alcançar os objetivos almejados e que possam ser executados de maneira eficiente, maximizando os recursos disponíveis.

O seu aspecto situacional está relacionado à análise crítica dos cenários futuros e traçar as estratégias, os planos e os rumos da gestão com o objetivo de se concentrar esforços no objetivo de se concretizar sua missão, tendo em vista sua definição e a obtenção de objetivos nos resultados reais em saúde pública (SILVA; PASTOR; STÁBILE, 2015).

**IMPORTANTE:**

O Ministério da Saúde utiliza-se de um planejamento voltado à estrutura e às escolhas estratégicas (ou resultados), que são divulgadas como objetivos ou diretrizes para os níveis executores. Trata-se de uma estratégia de gestão por resultados, voltados especialmente às escolhas estratégicas que orientam a organização, focados nos resultados perseguidos (PAULO, 2016).

Branco *et al.* (2010) explicam que o planejamento estratégico especificamente utilizado para a gestão da saúde foi impulsionado pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), na década de 1980, como uma alternativa política, pedagógica e gerencial para se concretizar as melhorias idealizadas na prestação de serviços de saúde em contraposição às ações não coordenadas e pouco eficazes até então executadas.

**IMPORTANTE:**

O planejamento estratégico enxerga o serviço de saúde como um todo, considerando o seu ambiente e definindo sistemas como um conjunto de partes que integrantes, porém, interdependentes. A análise e o monitoramento do ambiente permitem identificar ameaças e oportunidades, que o ambiente externo e interno condicionam (SILVA; PASTOR; STÁBILE, 2015)

O planejamento estratégico também traz o foco na construção a partir das observações de todos os profissionais envolvidos na prestação de serviços de saúde.

Esse delineamento se faz de forma dinâmica e contínua, renovando a compreensão das necessidades de saúde das populações, de práticas profissionais e de organização do trabalho em transformação mútua e permanente (BRANCO *et al.*, 2010). Autores do planejamento estratégico defendem que este deve ser realizado considerando-se momentos distintos, cada uma seu tempo.

De acordo com Matus (1996 apud RIEG *et al.*, 2014), em termos estruturais, o PES é composto de quatro momentos interativos: (1) o explicativo; (2) o normativo; o (3) estratégico; e (4) o tático-operacional.



SAIBA MAIS:

Carlos Matus, criador do Planejamento Estratégico Situacional foi um economista chileno, pós graduado em Harvard, ministro e presidente do Banco Central chileno durante o governo Allende (FIGUEIREDO FILHO; MÜLLER, 2002). Saiba mais em <<https://bit.ly/2JGTgbU>>.

Sá e Pepe (2000) explicam que:

1. no momento explicativo os atores identificam os problemas e procuram compreendê-los, buscando explicações sobre como os mesmo se manifestam, sua origem, sua existência, suas causas e suas consequências;
2. no momento normativo define-se os resultados almejados e como enfrentá-los.



NOTA:

Nessa etapa determina-se as operações e as ações a serem executadas para se alcançar as metas, todos os recursos necessários, os responsáveis, dentre outros aspectos do desenho do plano de intervenção sobre os problemas;

3. no momento estratégico compreende-se o grau de dificuldade (viabilidade) para realizar as operações e alcançar os resultados definidos como metas. É o momento de se analisar a motivação dos atores relevantes envolvidos no processo e sua capacidade de facilitar, de dificultar ou mesmo de impedir a realização das operações.

**NOTA:**

Desse modo, na sequência, deve-se buscar ferramentas estratégicas para garantir as ações propostas como negociação, persuasão, uso de autoridade e confronto.

4. no momento tático-operacional parte-se para a execução do plano propriamente dito. O PES se baseia na operação e na ação monitorados através do sistema de indicadores e de sinais que permitem ao gestor corrigir possíveis falhas em sua condução, até mesmo antecipando situações para intervenção. Desse modo, como etapa importante, o momento tático-operacional deve ser bem executado e avaliado continuamente.

Visão Tático-operacional

O momento tático-operacional é uma etapa extremamente importante do planejamento estratégico em saúde pois representa aquela em que as atividades serão efetivamente executadas, tendo os usuários como objeto das ações.

De modo geral, trata-se das ações de saúde desempenhadas pela equipe e que surtirão os efeitos sociais almejados: melhoria contínua da qualidade de vida e saúde da população assistida.

Desse modo, o PES define o momento "tático operacional", como o momento que trata especificamente da ação, tendo como suporte o plano definido nas etapas anteriores, delineado, com os objetivos almejados e o caminho a ser trilhado.

Este momento deve ser também o ponto de se redesenhar o plano e aprimorá-lo frente às contingências que porventura forem aparecendo ao longo de sua execução (BUSATO, 2017).

Por isso é importante a participação e a comunicação efetiva da equipe no momento tático operacional para que a execução seja acompanhada da análise diária durante as ações em saúde possibilitando a atualização dinâmica do plano.

Planejamento e Implementação de um Modelo Assistencial em Saúde

Qualquer planejamento e implementação em uma organização devem seguir passos bem definidos para uma sequência racional e utilizar-se de ferramentas administrativas exitosas tanto nos setores privados quanto públicos. Uma ferramenta usual nesse sentido é o ciclo do PDCA.

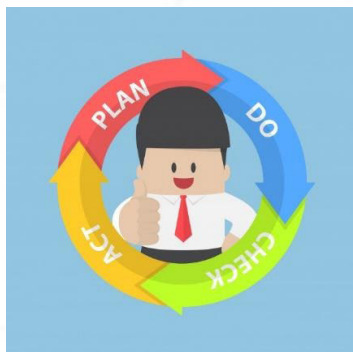


IMPORTANTE:

O ciclo PDCA é reconhecido como um processo de melhorias e controle de processos nas organizações. Porém, para se ter sucesso, é fundamental que todos os funcionários tenham domínio de sua utilização. Basicamente, o ciclo PDCA consiste no controle e na busca de resultados eficazes e confiáveis em todas as atividades de uma organização.

É uma ótima ferramenta para se acompanhar e avaliar as melhorias no processo uma vez que padroniza informações de controle, evita erros e torna as informações mais fáceis de compreensão. O ciclo do PDCA é composto por quatro etapas, sendo, em inglês: P = Plan (planejar); D = Do (fazer); C = Check (checar); A = Act (corrigir) (SANTOS; MIRAGLIA, 2009).

Figura 5 – O Ciclo do PDCA é ferramenta usual no controle de processos organizacionais.



Fonte: Freepik

Cardoso et al. (2010), explica que:

- O "P", planejamento, consiste na definição de metas sobre os itens de controle (indicadores) e o estabelecimento do caminho a se seguir para o alcance das metas propostas.
- O "D" consiste na execução das tarefas exatamente como definidas no plano e na coleta dos dados para avaliação do processo.
- No "C", verificação, trabalha-se a partir dos dados coletados na execução, o cálculo dos indicadores de resultado e a sua comparação com a meta planejada.
- O "A", atuação corretiva, consiste na detecção dos desvios e na intervenção no sentido de realizar as correções evitando-se que o problema ocorra novamente.

Dessa forma, o PDCA pode auxiliar os gestores na avaliação do sistema de saúde com informações consistentes para a tomada de decisão racional e a concepção de novos mecanismos, como o faz o planejamento estratégico situacional em saúde.

Planejamento Estratégico Situacional

O planejamento é a etapa do processo gerencial que se ocupa do estabelecimento de um conjunto atividades visando o alcance dos objetivos. Nas organizações de saúde, diz respeito ao processo de tomada de decisão por parte do gestor, responsável por definir as metas a serem alcançadas.

Em termos gerais, visa à definição prévia do que deve ser executado, como, quem, onde e quando executá-lo. Esse conjunto de ações contempla as estratégias que adotadas pela organização para sua atuação junto aos usuários (FALSARELLA; JANNUZZI, 2017).

**SAIBA MAIS:**

O Ministério da Saúde fomenta o monitoramento e a avaliação constante das ações preconizadas na estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2005). Leia mais em <<https://bit.ly/3bWKlWg>>.

O planejamento representa um momento de compartilhamento de poderes e, sendo assim, deve-se fomentar a definição de estratégias coletivas e solidárias, a ampla divulgação e a capacitação dos trabalhadores para a execução das atividades propostas.

Ao se realizar o planejamento é necessário que a organização seja vista como um todo e que possa adotar uma perspectiva de futuro. Para que isso seja possível, é necessário realizar uma análise do contexto externo e interno da organização para que se possa definir sua missão, sua visão e seus valores (GELBCKE et al., 2006).

Para que uma organização determine os objetivos que atendam à sua necessidade interna ela precisa estabelecer metas e planos de ação, mas, principalmente, divulgá-los e capacitar os seus trabalhadores para que os mesmos se comprometam e se responsabilizem com a missão institucional.

**NOTA:**

Nesse processo de construção, devem ser traçados a missão, a visão, os valores, as oportunidades e as ameaças do ambiente externo, as forças e as fraquezas do ambiente interno e a partir do diagnóstico situacional.

A partir disso podem ser estabelecidos os objetivos estratégicos e o plano de ação, destacando-se a força do processo de discussão, para uma construção coletiva (GELBCKE et al., 2006).

Falsarella e Jannuzzi (2017) explicam que os produtos resultantes da elaboração do planejamento estratégico podem ser assim definidos:

- Visão: sonho estratégico da organização, compartilhado e supostamente alcançável em um intervalo de tempo definido.
- Missão: representa objetivamente a identidade, o propósito, a razão da existência, o público-alvo e a área de atuação da organização.
- Objetivos estratégicos: tradução clara dos anseios da posição futura que a organização busca alcançar.
- Metas e indicadores: as metas determinam aonde se quer chegar e os indicadores são padronizados para acompanhar se as mesmas estão sendo alcançadas.
- Estratégias: definem o caminho das ações para que os objetivos estratégicos e as metas sejam alcançadas.

À análise do ambiente interno e do ambiente externo para a identificação de pontos positivos e de pontos negativos a serem trabalhados, dá-se o nome de Análise SWOT.

As análises de cenário são base para a definição de planos estratégicos. A definição dos elementos do ambiente de tarefa (próximo à organização) e do ambiente geral (contextual), estrutura o modelo básico para a formação da estratégia (SWOT em idioma inglês: *strengths*, forças; *weaknesses*, fraquezas; *opportunities*, oportunidades; e *threats*, ameaças) é etapa fundamental para a elaboração do planejamento estratégico situacional (GONZALEZ, 2009).

O planejamento estratégico, através da definição da missão, da visão e dos valores da saúde pública, realizando o diagnóstico de seu ambiente interno e externo, é ferramenta efetiva na melhoria da qualidade de saúde prestada aos usuários ou mais uma mera formalidade em um setor já altamente burocratizado?

A Análise SWOT, em português chamada de Matriz FOFA (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é um instrumento

usualmente utilizado no campo do planejamento e de gestão, facilitando a sistematização e a observação dos pontos fortes (Fortalezas e Oportunidades) e das fragilidades (Fraquezas e Ameaças) de uma organização, seja ela pública ou privada, e de aplicação na área da saúde pública. Nesse contexto, distingue-se o que é próprio (Fortalezas e Fraquezas), sobre o qual se tem governabilidade, do que é externo (Oportunidades e Ameaças) e que devem ser considerados (GOMIDE et al., 2015).



RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Concluímos nesse capítulo em que foram apresentadas as ferramentas gerenciais no intuito de se alcançar a eficiência administrativa na gestão pública da saúde, ponto de grande relevância deve merecer os esforços dos gestores. Vimos que a gestão da qualidade se baseia, principalmente, no atendimento aos requisitos dos clientes que, no SUS, estão intimamente ligados ao respeito aos princípios seus finalísticos e diretrizes. Estudamos também que o Planejamento Estratégico Situacional é fundamental para qualquer organização, inclusive as organizações da área de saúde que, para atender à população, englobando o gerenciamento de uma série de operações que envolvem muitos profissionais e diversos insumos. Discutimos que o PES é útil na resolução de problemas por meio do delineamento de ações estratégicas; entretanto, sua eficácia depende do grau de comprometimento dos participantes.

Desafios para a Organização dos Serviços de Saúde no Brasil Contemporâneo



INTRODUÇÃO:

Ao finalizar este capítulo você irá compreender como a economia da saúde é uma ciência que auxilia os gestores públicos no processo decisório sobre a alocação dos limitados recursos na saúde. Também veremos como se procede a análise da incorporação de tecnologias, seus custos agregados e a viabilidade a partir das avaliações econômicas em saúde. Animado para desenvolver esta competência? Então vamos em frente!

O SUS e o Estado

O SUS representa a mais ambiciosa e abrangente política pública de saúde já formulada no Brasil. Sua proposta demonstra claramente a relação do Estado enquanto provedor do sistema, definindo as suas funções frente aos usuários.

Hoje, envolto em uma série de "novos problemas" como o acolhimento, a mercantilização da saúde, a ausência da adoção de parâmetros de gestão baseados na noção de eficiência, no custo/efetividade, no custo/benefício e pelo flagrante subfinanciamento, em que os recursos que não são suficientes para se fazer cumprir os compromissos preconizados na Constituição Federal (BASSINELLO, 2014).

Outra questão importante é a relação do Estado com SUS. O direito à saúde não pode ser separado do direito à vida, biológica e social. O conceito de saúde vai muito além do aspecto biologicista e enreda-se nos campos da alimentação, condições de trabalhos, moradia, educação, saneamento básico, meio ambiente, lazer, informação (ALMEIDA, 2013).

Isso aumenta as responsabilidades com o provimento das condições necessárias à promoção e a manutenção da saúde da população.

O conceito ampliado que apresenta a saúde como um fenômeno complexo, resultado de um conjunto de determinantes, responsabiliza o Estado no provimento ao direito de constitucional de saúde, e no trabalho das condicionantes ligadas aos aspectos demográficos, epidemiológicos, nutricionais e tecnológicos, dentre outros (ALMEIDA, 2013).



IMPORTANTE:

Bassinello (2014) defende que o SUS desafia racionalidades ao se manter como uma proposta social que busca avançar na construção de um sistema universal de saúde para um país continental, populoso, que vive na periferia do capitalismo, conhecido pelas enormes desigualdades sociais.

O futuro do SUS encontra-se, inexoravelmente, atreladas ao êxito do Estado na formulação de suas políticas públicas voltadas ao enfrentamento dos problemas sociais do país. Por se tratar de um problema social construído historicamente, os esforços governamentais para a erradicação das desigualdades sociais representam o maior desafio para a efetivação da saúde universal no Brasil.

O SUS é o único sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 190 milhões de pessoas, em um país onde 80% dos usuários dependem exclusivamente dele para acesso aos serviços de saúde (MINAS GERAIS, 2018). Saiba mais em < <https://bit.ly/39JwaaR>>.

Outro dos maiores problemas na gestão atual da saúde é a capacidade dos governos e dos gestores em enxergar e trabalhar a economia da saúde. Entender que a saúde pública possui natureza altamente econômica e deve ser tratada com vistas à tomada de decisão baseadas em parâmetros econômicos, pode auxiliar na otimização dos recursos e na busca pela eficiência.

Estudos de Avaliação Econômica em Saúde

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018):



DEFINIÇÃO:

a Economia da Saúde é responsável por promover o uso racional e eficiente dos recursos públicos na área da saúde, a partir da construção de uma cultura do uso de indicadores e de parâmetros econômicos para a tomada de decisão racional.

Trata-se de uma ciência multiprofissional e interdisciplinar, que engloba profissionais da área de saúde, administração, economia, sociologia, dentre outros, com o objetivo de promover as condições para que as ações e os serviços de saúde sejam prestados de forma eficiente, equitativa e com qualidade para melhor acesso da população, respeitando, assim, os princípios da universalidade, da igualdade e da integralidade da atenção à saúde, estabelecidos na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde.

Outra questão importante na alocação e na otimização dos recursos em saúde é a compreensão da demanda.



DEFINIÇÃO:

Entende-se que a "demanda" por um bem ou serviço pode ser conceituada como sendo como a quantidade do mesmo que os usuários desejam consumir em um período de tempo definido (IUNES, 1995).

Considerando-se as restrições orçamentárias em uma realidade em que as demandas por bens e serviços de saúde são crescentes, opta-se por realizar análises econômicas para que a aplicação dos escassos recursos se faça de maneira racional e maximizada.

A teoria do bem-estar é a base metodológica da avaliação econômica em saúde. Sua base teórica é aplicada na busca da maximização da satisfação da população a partir da alocação racional dos recursos disponíveis.

Nessa avaliação, a eficiência alocativa tem como fundamento doutrinário garantir que alguns indivíduos possam melhorar, sem que outros necessitem piorar seus estados de saúde e de qualidade de vida.

A avaliação econômica engloba quatro tipos de estudo:

- 1.** Custo-efetividade;
- 2.** Custo-utilidade;
- 3.** Custo-benefício;
- 4.** Custo-minimização.

A diferença entre as análises é a forma de se mensurar os resultados em saúde (SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016).

Brasil (2008), explica os parâmetros da avaliação econômica em saúde, a saber:

- A análise de minimização de custos é a análise mais simples e considera a economia de recursos monetários quando permanecem os mesmos desfechos clínicos na saúde dos usuários;
- A análise de custo-benefício é considerada a mais abrangente e contempla todos os aspectos da eficiência alocativa, no qual os custos e benefícios são relatados usando uma métrica comum (unidades monetárias). Esse estudo permite avaliar os benefícios à saúde por unidade monetária aplicada.
- Na análise de custo-efetividade não se atribui valor monetário aos impactos das intervenções em saúde, considerando número de doenças evitadas, internações prevenidas, casos detectados, número de vidas salvas ou anos de vida salvos.

- As análises de custo-utilidade são um tipo especial de custo-efetividade, na qual a medida dos efeitos de uma intervenção considera a medição de qualidade de vida relacionada com a saúde em que a unidade de medida do desfecho clínico utilizada é a "expectativa de vida ajustada para qualidade" ou "anos de vida ajustados pela qualidade".



SAIBA MAIS:

O papel fundamental do Estado na reafirmação da saúde como direito constitucional em plena tendência mundial da mercantilização da saúde (CORREIA; OMENA, 2013). Leia mais sobre o assunto em: <<http://bit.ly/2DcJV3W>>

Assim, através da avaliação econômica em saúde pode-se promover uma alocação dos recursos limitados frente a uma realidade de demanda crescente de bens e de serviços de saúde, na busca da eficiência e na otimização dos custos operacionais do sistema de saúde.

Economia de Escala

As ações da atenção primária são conhecidas pelas baixas complexidade, tecnologia e custos. Porém, os níveis secundário e terciário envolvem incremento tecnológico, especialização profissional e consequente aumento de custos em escala.



REFLITA:

É desafiador enfrentar o aumento dos custos em saúde, gerados pela incorporação tecnológica, pela utilização de medicamentos mais avançados, dentre outros. Esses fatores geram ganhos e custos, aumentando a eficiência e simplificando os processos (SOLLA; CHIORO, 2012).

A economia de escala representa o aumento da produção total de serviços de saúde sem um aumento proporcional no custo dessa produção. Assim, o custo médio por serviço e/ou produto tende a reduzir com o aumento da produção (SOLLA; CHIORO, 2012).

**REFLITA:**

A economia de escala representa um desafio para os gestores de saúde pública, porque aumenta a necessidade de planejamento, de regulação do sistema e o desenho de redes assistenciais que incluam, de maneira eficiente, os serviços de saúde dos três níveis de atenção (SOLLA; CHIORO, 2012).

A economia de escala visa a sustentabilidade por permitir o aumento da oferta com a redução de custo operacional ou do produto ofertado, acarretando na otimização da alocação de recursos.

Para que isso aconteça no conceito de redes de saúde, faz-se necessário uma articulação adequada dos serviços regionalizados que viabilizem a continuidade das ações de saúde e efetivem a integralidade (TESSER; POLI NETO, 2017).

Vale lembrar que esta integração necessita partir da atenção primária, porta de entrada do sistema, e que essa ordene os fluxos e contra-fluxos, referências e contra-referências do sistema.

É fato que essa integração trará vantagens como a melhoria da qualidade da atenção, a redução de custos com economia de escala e o aumento da eficiência do SUS (MENDES, 2011).

Incorporação tecnológica em saúde

A área de atenção especializada envolve um conjunto de ações, de práticas e técnicas assistenciais de cuidado conhecidas pela incorporação de uma metodologia que envolve cada vez uma maior densidade tecnológica, denominada tecnologia especializada.

**DEFINIÇÃO:**

A tecnologia em saúde é tida como aquela relacionada à promoção da saúde, à prevenção, ao tratamento de doenças e a reabilitação de indivíduos. Como exemplos de tecnologias em saúde temos medicamentos, produtos biomédicos, procedimentos, exames e sistemas de informação utilizados nas ações e nos serviços de saúde ofertados à população (BRASIL, 2016).

As tecnologias em saúde são aplicadas desde a prevenção de doenças até o tratamento e a recuperação da saúde dos indivíduos. Sua utilização correta por parte dos profissionais da saúde é fundamental para aumentar o benefício para os usuários (BRASIL, 2016).

Nem sempre um menor preço individual por produto/serviço em saúde gera um menor custo total por procedimento/tratamento.

Nas redes de assistência encontramos serviços com grande diversificação das ações, de tecnologia e de custos agregados, geralmente, os serviços de menor densidade tecnológica, provenientes da atenção primária, devem ser dispersos no território, em contraposição àqueles de maior densidade tecnológica, como os hospitais e os serviços de diagnóstico por imagem que tendem a ser concentrados.

Desse modo, serviços de saúde coordenam-se numa rede estratégica, composta por distintas densidades tecnológicas que devem ser distribuídos, espacialmente, de forma otimizada (OMS, 2000; BRASIL, 2015).

Os serviços que compõem as RAS devem ter capacidade técnica e operacional dentro do que prevê a sua complexidade. A sua capacidade tecnológica deve ser suficiente para garantir que os problemas de saúde dos usuários que procuram aquele ponto de assistência com segurança e qualidade.

Figura 6 – Exemplo de tecnologia biomédica de alto custo.



Fonte: Freepik

Considerando-se a sustentabilidade econômico-financeira, esses serviços necessitam de incremento tecnológico em conformidade com as variáveis de planejamento baseados em necessidades de saúde da população por ele atendidas, seja na atenção primária ou nos referenciados por ela para os níveis secundário e terciário (BRASIL, 2012).

Os indivíduos que enfrentam uma doença necessitam de exames, de tratamentos e de cuidados adequados ao seu tipo de patologia para que possa restabelecer sua saúde.

Mesmo que as ações da atenção primária possuam grande efetividade, não possuímos o conhecimento que evite o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças particulares que irão demandar o incremento de especialização profissional e de tecnologia biomédica que representam, atualmente, elevados custos aos sistemas de saúde (BRASIL, 2016).



IMPORTANTE:

Por esse motivo e considerando-se que os recursos disponíveis para a saúde são limitados e carecem de aplicação racional e maximizada faz-se, extremamente, pertinentes as avaliações de tecnologia em saúde

Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS)

A avaliação tecnológica em saúde (ATS) é um processo baseado em evidências que busca analisar opções e desfechos da utilização de tecnologias em saúde, considerando a assistência profissional, social, questões financeiras, econômicas e éticas (BRASIL, 2016).



EXPLICANDO MELHOR:

A avaliação de tecnologia engloba as análises e as decisões sobre quais opções em saúde devem ser ofertados, baseando-se na necessidade da população, nos benefícios, na efetividade, na utilidade, e nos custos econômicos.

A tomada de decisões sobre as opções de tratamentos, medicamentos, procedimentos e exames, por exemplo, fornecidos pelo sistema público de saúde devem ser racionalmente tomados baseando-se em custos e evidências clínicas de resultados aos usuários (BRASIL, 2012).

Algumas perguntas podem ajudar na escolha da tecnologia a ser padronizada, como apresenta o Quadro 1.

Quadro 1 - Evidências científicas utilizadas na avaliação de tecnologias em saúde

Questionamentos
A tecnologia funciona?
Que benefício a tecnologia fornece e para quem?
Quanto custa a tecnologia (para os serviços de saúde, para o paciente, etc), incluindo os custos os chamados "custos de oportunidade"?
Ou seja, o que podemos ganhar se os recursos forem gastos com outros cuidados em saúde comprovadamente eficientes?
A tecnologia funciona naquele contexto de saúde em que se encontra?

Fonte: Brasil (2016)

A ATS é uma forma de pesquisa que avalia as consequências no curto e no longo prazo do uso das tecnologias em saúde. É um processo multidisciplinar que resume informações sobre as questões clínicas, sociais, econômicas éticas e organizacionais relacionadas ao uso da tecnologia em saúde de uma maneira robusta, imparcial, transparente e sistemática, que segue métodos adequados para a tomada de decisão (BRASIL, 2016).

EXEMPLO: Para a padronização de um medicamento, por exemplo, deve-se analisar seu custo relacionado à eficácia (resultado clínico), a segurança (risco de malefícios à saúde), a efetividade (como ele age no contexto real), a utilidade (anos de vidas ganhos e qualidade de vida associada em casos de tratamento crônico) e o impacto social.

A partir do resultado das análises da avaliação de tecnologias em saúde se define a viabilidade da incorporação tecnológica no âmbito do SUS.

**NOTA:**

A aplicação da Economia da Saúde nas análises de medicamentos otimizando custos e desfechos é chamada de Farmacoeconomia (PACKEISER; REST, 2014).

Grande parte dos esforços de pesquisas científicas e industriais que visam o desenvolvimento e a produção de novas tecnologias em saúde se destina à atender os serviços de atenção especializada (ambulatório e hospitalar).

**IMPORTANTE:**

Diversos estudos demonstram grande aumento do número de tecnologias produzidas e incorporadas nos últimos anos, associadas à queda das taxas de mortalidade geral, materno-infantil, cardiovascular, dentre outras, demonstrando eficiência nos investimentos governamentais (BRASIL, 2012).

Vale ressaltar que a incorporação tecnológica em saúde extrapola o uso de equipamentos e de medicamentos e o âmbito da atenção especializada, englobando pesquisa acadêmica, produção de serviços de saúde, condutas e mudanças nos processos de trabalho.

As restrições de orçamentárias geram desigualdades nos tratamentos de saúde no setor público e particular.

Porém, o processo de incorporação tecnológica vem acontecendo de modo acelerado e desregulado, modulado pelo mercado da saúde que nem sempre age eticamente no mundo competitivo, e gerando grandes desigualdades nos tratamentos de saúde devido às restrições de orçamento (BRASIL, 2016).

É importante lembrar que a oferta de tecnologias em saúde excede a capacidade de oferta do SUS, fazendo assim, com que seja necessária a adoção de escolhas difíceis quanto à alocação de recursos escassos em saúde.

Esse fato se agrava quando as regras decisórias existentes são inadequadas para orientar a escolha dos maiores aos usuários. Agregando-se às falhas de planejamento e de regulação, à incorporação de novas tecnologias biomédicas, levar a resultados economicamente desastrosos sem resultar no benefício almejado (BRASIL, 2012).

**REFLITA:**

Prezado aluno, agora que discutimos sobre os diversos modelos de assistência à saúde, reflita qual seria um modelo que mais se adapte à realidade da população brasileira e às políticas do SUS. Analise também as fontes de financiamento e as estratégias de gestão mais adequadas.

**RESUMINDO:**

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Nesse capítulo discutimos como a Economia da saúde é uma ciência multidisciplinar que apresenta ferramentas e subsídios para que governantes e gestores tomem as melhores decisões no que tange ao financiamento e a alocação dos limitados recursos destinados à saúde pública no país. Vimos como avaliar a viabilidade de se incorporar novas tecnologias em saúde, principalmente, quando essas envolvem aumento de complexidade e onera os cofres públicos. Por fim, analisamos como agir frente à demanda de saúde da população e à capacidade financeira, que limita a destinação de recursos para sanar as grandes e importantes necessidades de saúde da população.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Nemésio Dario. **A saúde no Brasil, impasses e desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde: SUS.** Rev. Psicol. Saúde, Campo Grande, v. 5, n. 1, p. 01-09, jun. 2013. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-093X2013000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

BASSINELLO, G. et al. **Saúde coletiva.** 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

BRANCO, J. P. et al. **Planejamento estratégico e a saúde pública: um estudo do programa saúde da família.** XXX Encontro Nacional De Engenharia De Produção Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente. São Carlos, SP, Brasil, 2010. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2621383/mod_folder/content/0/BRANCO_et_al_2010.pdf?forcedownload=1>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. **Ministério da Saúde.** Gestão do SUS: Economia da Saúde no MS. 2018. Disponível em <<http://portalms.saude.gov.br/gestao-do-sus/economia-da-saude>>. Acesso em: 02 jul 2019.

BUSATO, I. M. S. **Planejamento estratégico em saúde.** 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2017.

CORNETTA, V. K.; FELICE, S. A. **Desenvolvimento da qualidade: garantia da eficiência nos serviços de saúde.** Laes Haes, 1994.

CORREIA, A. D. M. S., et al. (Org.). **Modelo assistencial em saúde: os modelos assistenciais no Brasil.** In: Políticas públicas de saúde e processo de trabalho em saúde da família. Campo Grande, MS: UFMS: Fiocruz Unidade Cerrado Pantanal, 2010. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/15664>>. Acesso em: 01/02/2020.

CORREIA, M. V. C.; OMENA, V. C. **A mercantilização da saúde e a política de saúde brasileira**: a funcionalidade da saúde suplementar. Anais da VII Jornada Internacional de Políticas Públicas. UFMA. São Luís: Maranhão, 2013. Disponível em: <<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo3-estadolutassociaisepoliticaspublicas/pdf/amercentilizacaodasaudeeapoliticadesaudebrasileira.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

FARIA, H. P. et al. **Modelo assistencial e atenção básica à saúde**. 2. ed. Belo Horizonte: Nescon/UFMG, Coopmed, 2010. Disponível em < <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/1792.pdf>>. Acesso em 01/02/2020.

FERTONANI, H. P. et al. **The health care model**: concepts and challenges for primary health care in Brazil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 6, p. 1869-1878, June 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000601869&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

FIGUEIREDO FILHO, W. B.; MÜLLER, G. **Planejamento estratégico segundo Matus: proposta e crítica**. Do Natural, do Social e de suas Interações: visões geográficas. UNESP, 2002. Disponível em: <<http://www.rc.unesp.br/igce/geografia/pos/downloads/2002/planejamento.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

IUNES, R. F. **Demanda e Demanda em Saúde**. In: Economia da Saúde: Conceitos e Contribuição para a Gestão da Saúde. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília, outubro de 1995 Disponível em: <<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/CAP4.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

LABBADIA, L.L.; Matsushita, M. S.; PIVETA, V. M.; VIANA, T. A.; CRUZ, F. S. L. **O processo de acreditação hospitalar e a participação da enfermeira**. R Enferm UERJ, 2004.

LIMA, M. B. B. P. B. **Gestão da Qualidade e o Redesenho de Processos como Modelo de Desenvolvimento Organizacional em Hospitais Públicos Universitários**: o Caso do Hospital de Clínicas da UNICAMP. Universidade Estadual de Campinas. 2007. Disponível em: <<https://www.hc.unicamp.br/qualidade/TeseMariaBernadete.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

LORENZETTI, J. et al. **Gestão em saúde no Brasil: diálogo com gestores públicos e privados**. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 23, n. 2, p. 417-425, June 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072014000200417&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

MINAS GERAIS. **SUS**. 2018. Disponível em < <http://www.saude.mg.gov.br/sus> >. Acesso em: 01/02/2020.

MOROSINI, M. V. G. C. **Modelos de atenção e a saúde da família**. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. Disponível em: <<http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/l26.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

PAIM, J. S. **Modelos assistenciais**: reformulando o pensamento e incorporando a proteção e a promoção. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/6168/1/Paim%20JS.%20Texto%20Modelos%20Assistenciais.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

PAULO, L. F. A. **Planejamento estratégico e gestão por resultados**: o caso do Ministério da Saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, p. 981-1007, Set. 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312016000300981&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

PORTELA, M. C. **Avaliação da qualidade em saúde**. In: ROZENFELD, Suely. (Org.) Fundamentos da Vigilância Sanitária. 1ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, p. 259-269, 2000.

RIEG, Denise Luciana et al. **Aplicação de procedimentos do planejamento estratégico situacional (PES) para estruturação de problemas no âmbito**

empresarial: estudos de casos múltiplos. Gest. Prod., São Carlos , v. 21, n. 2, p. 417-431, jun. 2014 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2014000200014&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

SÁ, M. C.; PEPE, V. L. E. **Planejamento estratégico.** In: ROZENFELD, S., org. Fundamentos da Vigilância Sanitária [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2000, pp. 196-232. ISBN 978-85- 7541-325-8. Disponível em: < <http://books.scielo.org/id/d63fk/pdf/rozenfeld-9788575413258-12.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

SILVA, E. N.; SILVA, M. T.; PEREIRA, M. G. **Estudos de avaliação econômica em saúde:** definição e aplicabilidade aos sistemas e serviços de saúde. Epidemiol Serv Saude; 25(1): 205-207, 2016 Jan-Mar. Disponível em < <http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-27861695>>. Acesso em: 01/02/2020.

SILVA JUNIOR, A. G.; ALVES, C. A. **Modelos Assistenciais em Saúde:** desafios e perspectivas. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. p 27-41. ISBN: 978-85-98768-24-3. Disponível em: <http://www.uff.br/tcs2/images/stories/Arquivos/textos_gerais/4-_Modelos_Assistenciais_em_Sade_-_Aluisio_G._da_Silva_Jr_e_Carla_A._Alves.pdf>. Acesso em: 01/02/2020.

SILVA, L. A. M. ; PASTOR, C. S.; STÁBILE, S. **A importância do planejamento estratégico no ambiente organizacional:** um estudo sobre as dificuldades de gestão. Unicuritiba, 2015. Disponível em:<<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/download/1232/836>>. Acesso em: 01/02/2020.

TAMADA , R. C. P.; BARRETO, M. F. S.; CUNHA, I. C. K. O. **Modelos de gestão em saúde:** novas tendências, responsabilidades e desafios. Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP. 2013. Disponível em: <http://www.convibra.org/upload/paper/2013/38/2013_38_7937.pdf>. Acesso em: 01/02/2020.

TAJRA, S. F. **Gestão Estratégica na Saúde.** Reflexões e Práticas Para Uma Administração Voltada Para a Excelência. 2. ed. Editora Iatria. São Paulo, 2010.

BRASIL. Lei Complementar No. 141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o § 30 do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. Brasília: DF. 1990. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp141.htm>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. **Lei Nº 8689, de 27 de julho de 1993**. Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) e dá outras providências. Brasília: DF. 1993. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8689.htm>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Organização Pan-Americana da Saúde. Financiamento público de saúde. Brasília: 2013. 124 p. : il. – Série Ecos – Economia da Saúde para a Gestão do SUS; Eixo 1, v. 1. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/financiamento_publico_saude_eixo_1.pdf>. Acesso em: 01/02/2020.

BUSATO, I. M. S. **Planejamento estratégico em saúde**. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2017.

PAGLIOSA, F. L.; DAROS, M. A. **O relatório Flexner**: para o bem e para o mal. Rev. bras. educ. med., Rio de Janeiro, v. 32, n. 4, p. 492-499, Dec. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022008000400012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

SICKO: SOS saúde. **Direção de Michael Moore**. EUA: Dog Eat, Dog Films: Europa Filmes, 2007. 1 filme (123 min.): son., color.

SILVA JUNIOR, A. G.; ALVES, C. A. **Modelos Assistenciais em Saúde**: desafios e perspectivas. In: Márcia Valéria G.C. Morosini e Anamaria D.Andrea Corbo (org). Modelos de atenção e a saúde da família. Rio de Janeiro: EPSJV/ Fiocruz, 2007. p 27-41. ISBN: 978-85-98768-24-3. Disponível em: <http://www.uff.br/tcs2/images/stories/Arquivos/textos_gerais/4_Modelos_Assistenciais_em_Sade_-_Aluisio_G_da_Silva_Jr_e_Carla_A._Alves.pdf>. Acesso em: 01/02/2020.

ALMEIDA, A. G.; BORBA, J. A.; FLORES, L. C. S. **A utilização das informações de custos na gestão da saúde pública:** um estudo preliminar em secretarias municipais de saúde do estado de Santa Catarina. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 43, n. 3, p. 579-607, 2009. Disponível em: <<https://goo.gl/mYdUKV>>. Acesso em: 01/02/2020.

ALMEIDA, N. M. S. **Formação do enfermeiro e reorientação do modelo de assistência à saúde:** um estudo cartográfico. 2012. 107 f. Dissertação. Mestrado em Enfermagem e Saúde. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, Bahia, 2012. Disponível em: <<https://goo.gl/aUtWBt>>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. **Resolução nº 234, de 07 de fevereiro de 1992.** Norma Operacional Básica: SUS/1992 Brasília, DF, 07 fev. 1992. Disponível em: <<https://goo.gl/qAJxYj>>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 2.203, de 05 de novembro de 1996.** Norma Operacional Básica – NOB 1/96. Brasília, DF. 05 nov. 1996. Disponível em: <<https://goo.gl/6z68Pa>>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. **A Atenção Primária e as Redes de Atenção à Saúde.** Brasília: CONASS, 2015. Disponível em: <<http://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/A-Atencao-Primaria-e-as-Redes-de-Atencao-a-Saude.pdf>>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. **Resolução nº 258, de 07 de janeiro de 1991.** Norma Operacional Básica Nº 01/91. Brasília, DF, 07 jan. 1991. Disponível em: <<https://goo.gl/R7MU6h>>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Entendendo a Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS:** como se envolver. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

34 p.: il. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/entendendo_incorporacao_tecnologias_sus_envolver.pdf>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. **Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS 01/02**. Brasília, DF, 27 fev. 2002. Disponível em: <<https://goo.gl/57ldo>>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 95, de 26 de janeiro de 2001. **Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS NOAS-SUS 01/2001** Brasília, DF, 26 jan. 2001. Disponível em: <<https://goo.gl/C3akuJ>>. Acesso em: 01/02/2020.

MENDES, E.V. **As redes de atenção à saúde**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS. **The world health report 2000: health systems, improving performance**. Geneva, World Health Organization, 2000.

PACKEISER, Priscila Becker; RESTA, Darielli Gindri. **Farmacoeconomia: uma ferramenta para a gestão dos gastos com medicamentos em hospitais públicos**. Infarma - Ciências Farmacêuticas, [S.L.], v. 26, n. 4, p. 215-223, dec. 2014. ISSN 2318-9312. Disponível em: <<http://revistas.cff.org.br/?journal=infarma&page=article&op=view&path%5B%5D=683>>. Acesso em: 01/02/2020.

SOLLA, Jorge; CHIORO, Arthur. **Atenção ambulatorial especializada**. In: GIOVANELLA, Lígia et al. (Org.). Políticas e sistemas de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. cap. 17, p. 547-576. Disponível em: < http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/File/ATENCAO_AMBULATORIAL_ESPECIALIZADA_Solla_e_Chioro.pdf>. Acesso em: 01/02/2020.

TESSER, Charles Dalcanale; POLI NETO, Paulo. **Atenção especializada ambulatorial no Sistema Único de Saúde: para superar um vazio**. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 3, p. 941-951, Mar. 2017. Disponível

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232017002300941&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Avaliação para melhoria da qualidade da estratégia saúde da família: documento técnico**. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Série B. Textos Básicos de Saúde. Disponível em <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/doc_tec_amq_portugues.pdf>. Acesso em: 01/02/2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1645, de 02 de outubro de 2015**. Dispõe sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Brasília: DF. 2015. Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1645_01_10_2015.html>. Acesso em: 01/02/2020.

CARDOSO, A. T. et al. **O ciclo PDCA para a melhoria da qualidade dos serviços de consulta em uma unidade de saúde de Belém do Pará**. VII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Resende: RJ, 2010. Disponível em <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/216_O%20ciclo%20PDCA%20para%20a%20melhoria%20da%20qualidade%20dos%20servicos%20de%20consulta%20em%20uma%20unidade%20de%20Belem%20do%20Para.pdf>. Acesso em 01/02/2020.

FALSARELLA, O. M.; JANNUZZI, C. A. S. C. **Planejamento Estratégico Empresarial e Planejamento de Tecnologia de Informação e Comunicação: uma abordagem utilizando projetos**. Gest. Prod., São Carlos, v. 24, n. 3, p. 610-621, Sept. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2017000300610&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 01/02/2020.

GELBCKE, F. et al. **Planejamento estratégico participativo: um espaço para a conquista da cidadania profissional**. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 15, n. 3, p. 515-520, Set. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072006000300018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 01/02/2020.

GOMIDE, M. et al. **Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (Matriz FOFA) de uma Comunidade Ribeirinha Sul-Amazônica na perspectiva da Análise de Redes Sociais:** aportes para a Atenção Básica à Saúde. Cad. saúde colet., Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 222-230, Set. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-462X2015000300222&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

GONZALEZ, M. M. L. **Planejamento estratégico em saúde com base em determinantes: o caso do município de Campo Bom (RS).** Uma proposta metodológica para a gestão descentralizada. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, supl. 1, p. 1587-1597, Oct. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000800032&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.

SANTOS, E. A.; MIRAGLIA, S. G. E. K. **Arquivos abertos e instrumentos de gestão da qualidade como recursos para a disseminação da informação científica em segurança e saúde no trabalho.** Ci. Inf., Brasília, v. 38, n. 3, p. 80-95, dez. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652009000300006&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01/02/2020.



Modelos e Gestão de Serviços em Saúde

Hermínio Oliveira Medeiros



TeleSapiens